



M51: Profil bactériologique et épidémiologique des suppurations cutanées à *Staphylococcus aureus*

Dr Bounaidja Rachedi I, Dr Benharket M, Dr Bentorki A A, Dr Otmane A, Pr Nedjai S

INTRODUCTION-OBJECTIFS:

Staphylococcus aureus est l'un des principaux agents responsables des infections suppurées communautaires et nosocomiales. Sa capacité à produire diverses toxines et à développer une résistance aux antibiotiques, notamment aux bêta-lactamines, en fait un pathogène majeur de santé publique.

Objectifs :

Décrire le profil bactériologique et épidémiologique des suppurations à *S. aureus* et déterminer les taux de résistance aux principaux antibiotiques utilisés.

MATÉRIELS ET MÉTHODES :

Il s'agit d'une étude prospective descriptive menée au laboratoire de microbiologie de CHU DORBAN ANNABA sur une période de 1an (01Octobre 2024-31Octobre 2025)mois. Les prélèvements de pus ont été analysés selon les techniques standards d'isolement et d'identification. L'antibiogramme a été réalisé par la méthode de diffusion en gélose selon les recommandations du CLSI.

RÉSULTATS:

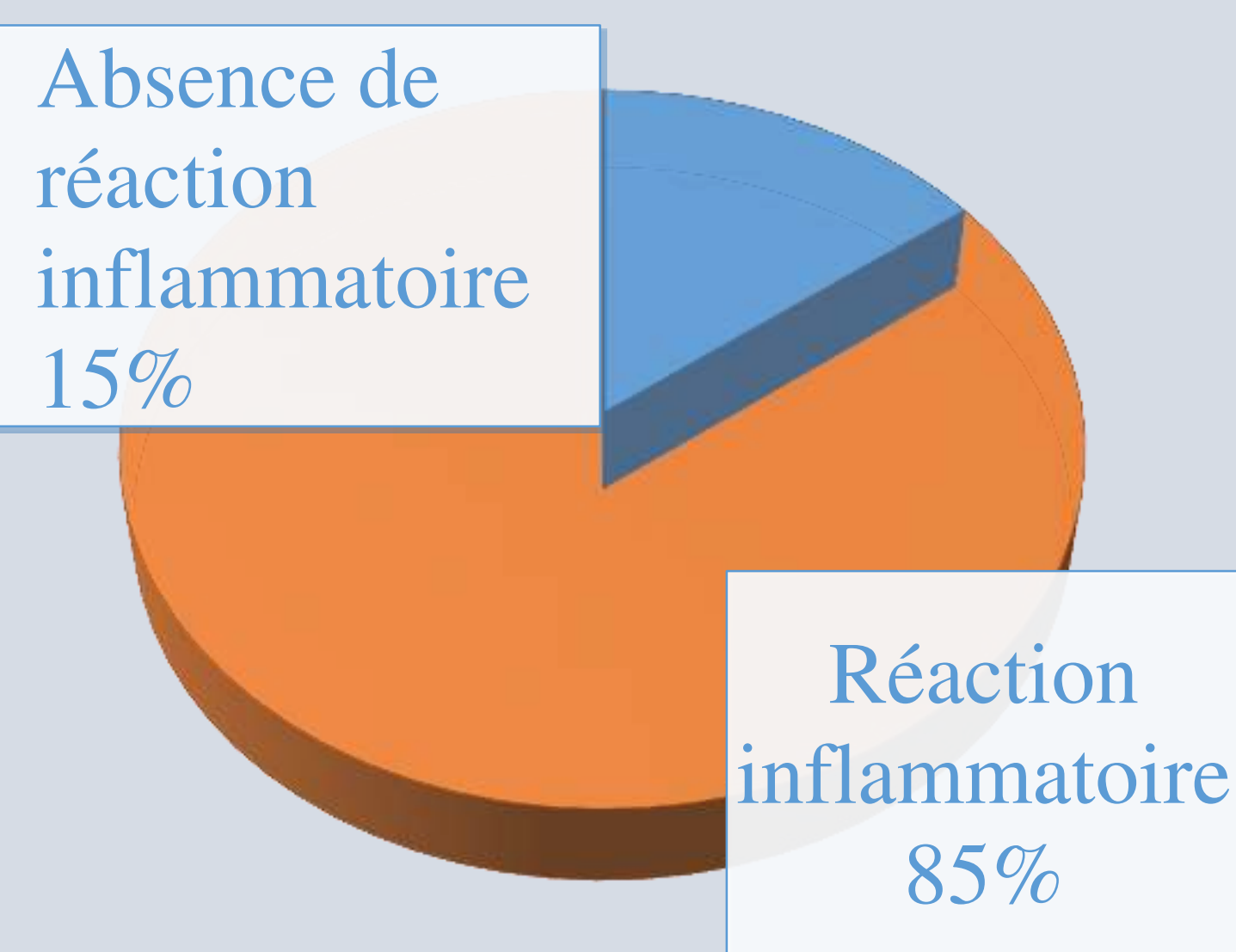


Figure 1: Répartition des prélèvements selon la réaction inflammatoire

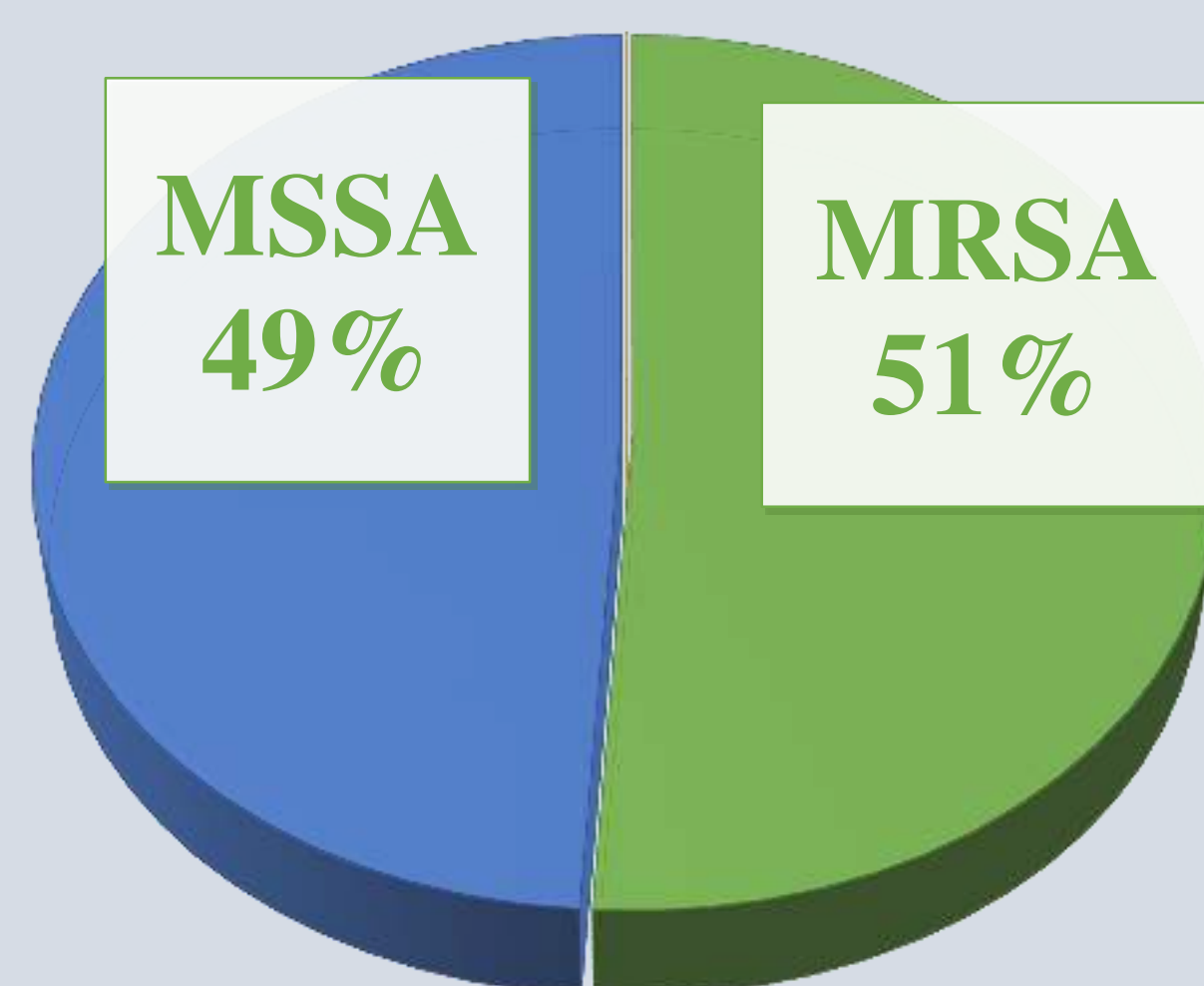


Figure 2: La résistance des isolats aux bêtalactamines

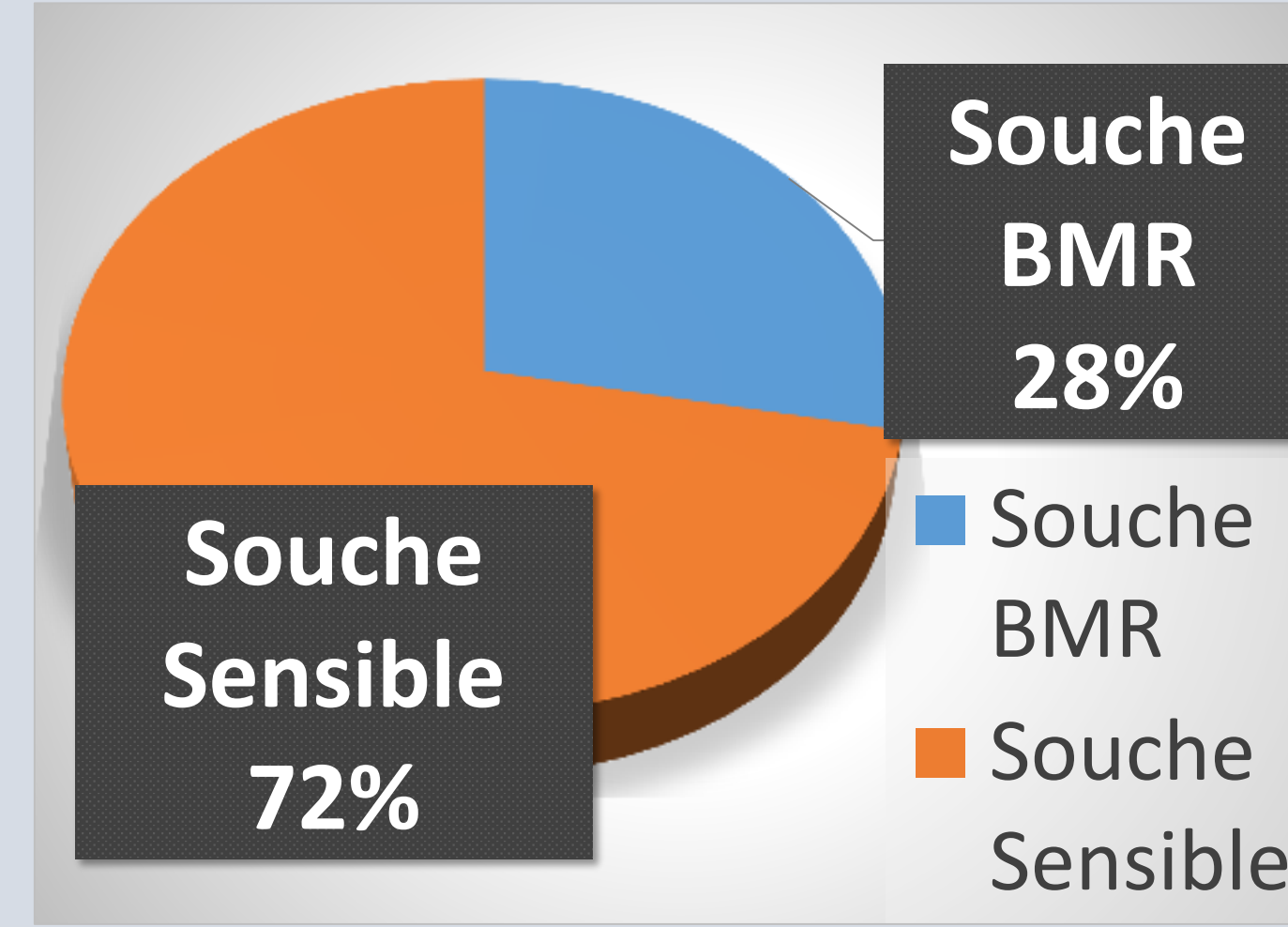


Figure 3: Pourcentage des souches multirésistantes

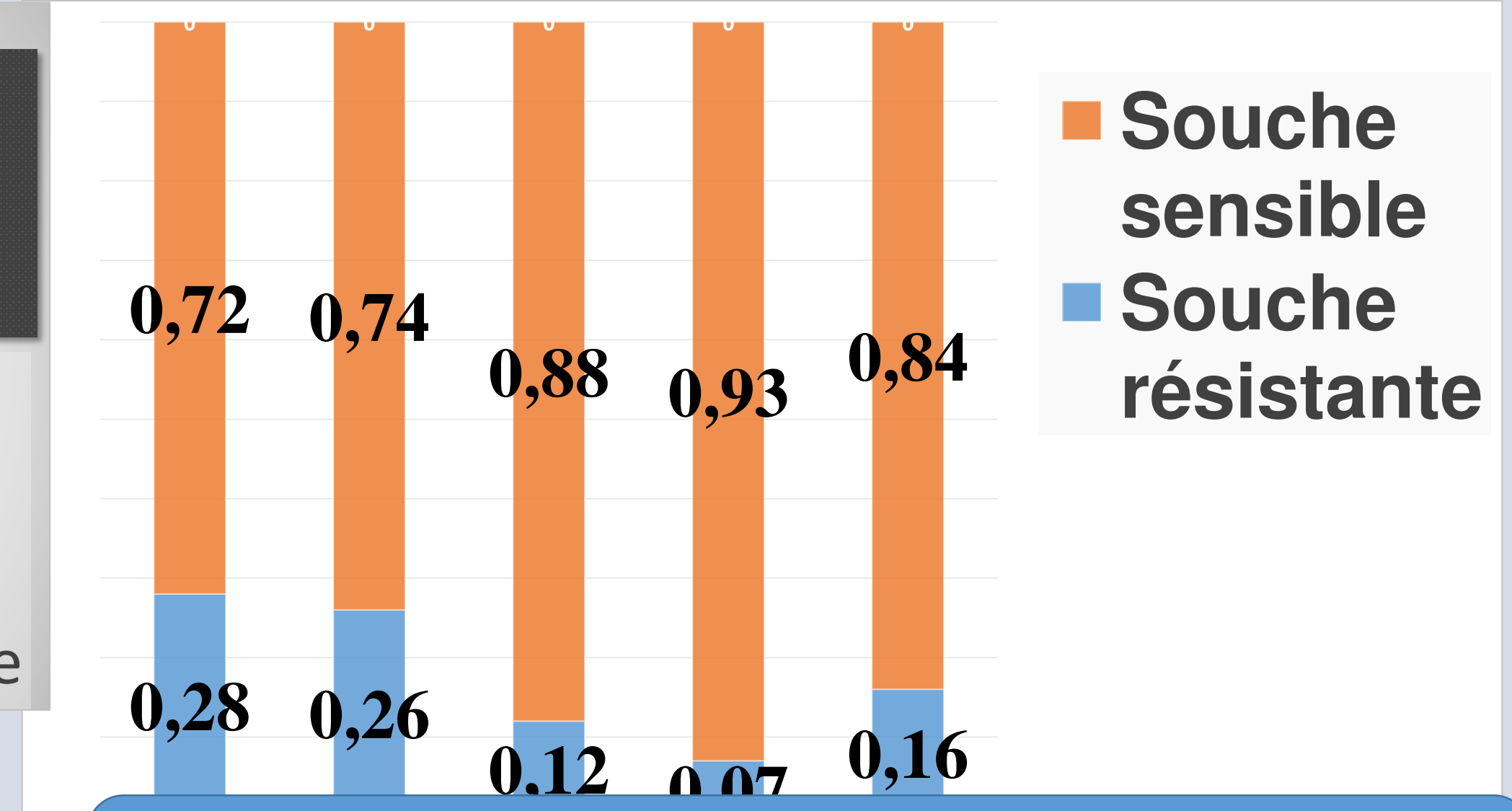


Figure 4: Profil de résistance des souches aux autres classes d'antibiotiques

DISCUSSION:

Les résultats montrent une forte expression clinique des suppurations cutanées, avec une réaction inflammatoire présente dans 85 % des cas. La résistance élevée aux bêta-lactamines (51 %) confirme la circulation importante de souches de *Staphylococcus aureus* résistantes, en cohérence avec les tendances récentes observées dans de nombreux pays. La présence de bactéries multirésistantes et les taux notables de résistance aux antibiotiques principaux pour le traitement de ce type d'infection, soulignent une pression antibiotique significative et la nécessité d'un suivi rapproché. La sensibilité majoritaire aux autres classes (aminosides, bactrim) reste encourageante, mais impose une surveillance continue. Globalement, ces données confirment l'évolution préoccupante du profil de résistance des souches impliquées dans les suppurations cutanées.

CONCLUSION :

Staphylococcus aureus reste un agent majeur des infections suppurées. Le suivi régulier de sa sensibilité est essentiel pour orienter une antibiothérapie rationnelle et prévenir la propagation des souches résistantes.

Références

- 1-Chambers HF, Deleo FR. Waves of resistance: *Staphylococcus aureus* in the antibiotic era. *Nat Rev Microbiol*. 2009;7(9):629-41.
- 2-Tong SYC, Davis JS, Eichenberger E, Holland TL, Fowler VG. *Staphylococcus aureus* infections: epidemiology, pathophysiology, clinical manifestations, and management. *Clin Microbiol Rev*. 2015;28(3):603-61.
- 3-World Health Organization (WHO). Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS) Report. WHO; 2023.
- 4-European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Antimicrobial resistance in the EU/EEA. Annual Epidemiological Report 2023.
- 5-Liu C, et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America for the treatment of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infections. *Clin Infect Dis*. 2011;52(3):e18-55.
- 6-David MZ, Daum RS. Community-associated methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: epidemiology and clinical consequences. *Clin Microbiol Rev*. 2010;23(3):616-87.
- 7-Stefani S, et al. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA): global epidemiology and harmonization of typing methods. *Int J Antimicrob Agents*. 2012;39(4):273-82.
- 8-EUCAST. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 2024.